炎症性肠病 ★★★（0~3题）

青壮年多见、抗生素多无效“UC 连续溃疡浅、CD 节段鹅卵石”

	溃疡性结肠炎 UC（2009、2020、2025）	克罗恩病 CD（2007、2019、2026）
好发部位	直肠及乙状结肠	回肠末端及邻近结肠
病变分布	连续 / 弥漫性	节段 / 跳跃性
主要症状	左下腹痛、黏液脓血便、里急后重 腹痛→便意→便后缓解（2009、2025）	右下腹痛、腹部包块 腹痛→进食→疼痛加重
结肠镜（首选和金标准）	浅溃疡	纵行裂隙状深溃疡、鹅卵石 / 铺路石样、非干酪肉芽肿
并发症（2017）	中毒性巨结肠（首选 X 线）：重度 UC 活动期最常见（2009、2013）（腹泻 / 便血 /P/T/Hb/ESR，2024）；低钾 / 钡灌肠 / 抗胆碱药 / 阿片药后；全腹压痛膨隆、肠鸣音↓、易急性穿孔；横结肠最严重、明显毒血症（血 WBC 显著↑） 癌变、出血、梗阻等	肠梗阻（最常见，2013、2019） 腹腔或肛周脓肿：充分引流、甲硝唑和喹诺酮类 瘘管（特征） 癌变、出血、急性穿孔等

控制炎症反应（升阶梯治疗，2008、2011）

	氨基水杨酸制剂（用于 UC）	糖皮质激素	免疫抑制剂	生物制剂和口服小分子药物
常用药	美沙拉嗪	泼尼松	硫唑嘌呤	英夫利昔单抗
活动期诱导缓解	轻中度 UC	ASA 不佳或重度 UC（腹泻≥ 6）首选 CD 首选（但肛瘘慎用激素）	√（但起效慢）	√
缓解期维持治疗	轻中度 UC	×	√	√